



## Strategische Konzeption und Brand-Entwicklung

**Strategiepapier für:** Simplimed GmbH

**Datum:** 27. Mai 2025

**Ansprechpartner:** Haroon Ahmad, Origem Medical Gruppe

**Empfänger:** Marcus Schmitz

**Strategisches Konzept zur Neupositionierung der SimpliMed GmbH**

**Ziel: Investorenrelevante Neuaufstellung einer spezialisierten Praxissoftware im Selbstzahlermarkt**



# INHALT

## **1. Ausgangslage & Kontext**

## **2. Analyse des Status Quo**

- 2.1 Nutzerverhalten & Kundenstruktur
- 2.2 Schlussfolgerungen für die Strategie
- 2.3 Kundenbasis & Preisstruktur
- 2.4 Strategische Ableitungen
- 2.5 Produktbestand & Marktwirkung
- 2.6 Nutzungsmuster
- 2.7 Technologisches Fundament

## **3. Strategisches Zielbild (2025–2027)**

## **4. Produktarchitektur & Monetarisierung**

- 4.1 Basismodul
- 4.2 Erweiterungsmodule
- 4.3 Migration & Preismodell
- 4.4 Patientenservices (perspektivisch)
- 4.5 Monetarisierung NutriShop24
- 4.6 Zukunftsperspektiven & Markttrends
- 4.7 Zentrales Therapeut:innen-Dashboard

## **5. Markt & Wettbewerb**

- 5.1 SoliPrax
- 5.2 Lemniscus
- 5.3 thevea
- 5.4 tomedo®

## **6. Produktentwicklung & Technologiekonzept**



## **7. Unique Selling Propositions (USP)**

- 7.1 Abrechnungs-Expertise
- 7.2 Monetarisierbare Plattform (NutriShop24)
- 7.3 Technologieplattform
- 7.4 Zielgruppenspezialisierung

## **8. Marketing & Vertrieb**

- 8.1 Migration Online-Kund:innen
- 8.2 Reaktivierung Offline-Kund:innen
- 8.3 Digitales Marketing & Co-Marketing

## **9. Businessplan & Investorenstrategie**

- 9.1 Personal IST-Stand
- 9.2 Empfohlene Personalerergänzungen (für 12-18 Monate Umsetzungszeitraum)
- 9.3 Abgleich empfohlene Rollen vs. bestehendes Organigramm
- 9.4 Kostenstruktur
- 9.5 Modellierter Umsatz- und Absatzentwicklung
- 9.6. Ausblick und Vision
- 9.7 Gesamtinvestition & Kapitalstrategie
- 9.8 Offene Finanzierungsfrage: Investoren, Kredite oder Fördermittel?

## **10. Kritische Erfolgsfaktoren & Handlungsempfehlungen**

## **11. Gesamtfazit**



## **1. Ausgangslage & Kontext**

Die SimpliMed GmbH agiert seit über zehn Jahren im Markt für Praxisverwaltungssoftware, primär im Bereich privatärztlicher und heilpraktischer Leistungen. Die Firma verfügt über rund 8.000 Lizenzen, von denen etwa 4.000 aktiv in der Online-Version betrieben werden. Die verbleibenden Lizenzen stammen aus einem älteren, offline-basierten Modell.

Der bestehende Kundenstamm zeichnet sich durch hohe Loyalität, stabile Nutzung und eine signifikante Spezialisierung auf Privatabrechnungen aus (GOÄ, GebüH, BBhV). Das System ist funktional umfangreich, aber technologisch nicht mehr konkurrenzfähig im Vergleich zu modernen SaaS-Angeboten. Die Optik ist veraltet, die Oberfläche komplex, und viele Features werden in der Praxis nicht genutzt.

Der Wunsch nach einem Investorenpitch markiert den strategischen Wendepunkt: Es geht nicht mehr um Wartung, sondern um Transformation – technologisch, wirtschaftlich und in der Markenidentität.



## 2. Analyse des Status Quo

Bevor eine neue Strategie entwickelt werden kann, muss die Realität umfassend verstanden werden. Diese Analyse fasst die derzeitige Leistungsfähigkeit, Marktresonanz und technologische Grundlage von SimpliMed zusammen. Sie bildet die Basis für alle folgenden Maßnahmen – sowohl im Hinblick auf das neue Produktdesign als auch auf die geplante Investorenansprache.

### 2.1 Nutzerverhalten & Kundenstruktur (Ist-Zustand)

Eine interne Auswertung der Nutzungsdaten zeigt ein differenziertes Bild der Anwendungstiefe:

- Multimandantenmodus: 40 % der Kunden verwenden das System mit mehr als einem Mandanten – meist aufgrund von Zweitpraxen oder Nebengewerben wie dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln.
- Kontakteverwaltung: 99 % der Kunden nutzen dieses Modul aktiv. Wer es nicht nutzt, verwendet vermutlich gar kein Modul ernsthaft.
- Privatabrechnung: 94 % nutzen aktiv die Fakturierung inkl. Mahnwesen – das Abrechnungsmodul ist damit das funktionale Rückgrat der Software.
- Terminplanung: 71 % nutzen die Terminplanung, davon nur 19 % auch die Online-Terminbuchung – was auf ein starkes Potenzial für digitale Erweiterung hinweist.
- Krankenblatt / Dokumentation: 47 % nutzen diese Funktion, primär zur Ablage von PDFs, Arztbriefen und Bildern – funktional als Dokumentenablage, weniger als strukturierte Akte.
- Rezeptmodul: 19 % nutzen die Rezeptierung aktiv.
- Buchhaltung: 11 % der Kunden verwenden das Buchhaltungsmodul, allerdings nur 6 % vollumfänglich mit Kontoumsätzen.
- Onlinefragebogen & digitale Unterschrift: Werden nur von 8 % genutzt – oft aus Unkenntnis über die Existenz des Features.
- Weitere Module: Textverarbeitung, Laborfunktionen, Wartezimmer etc. werden kaum verwendet.

### 2.2 Schlussfolgerung für die Strategie

Diese Daten bestätigen die Diagnose eines funktionsreichen, aber asymmetrisch genutzten Systems. Die hohe Nutzung von Abrechnung, Terminierung und Kontaktverwaltung zeigt, wo der eigentliche Kernnutzen liegt. Gleichzeitig existiert ein beträchtliches Wissens- und Aktivierungsdefizit bei vielen nützlichen Features.

Strategisch bedeutet das:

1. Fokussierung: Die Neuentwicklung sollte sich auf diese Kernmodule stützen.
2. Modularisierung: Zusatzfunktionen müssen sichtbar und gezielt aktivierbar gemacht werden.



3. Kommunikation: Es braucht ein durchgängiges Onboarding, das ungenutzte Potenziale erschließt.
4. Vermarktung: Funktionen wie digitale Unterschrift oder Onlinefragebögen haben ein hohes Upselling-Potenzial – wenn sie besser inszeniert werden.

Diese Analyse macht deutlich: Das Produkt hat funktionale Stärke, aber strategische Streuung. Der neue Fokus muss lauten: Systematisierung vor Expansion.

## 2.3 Kundenbasis & Preisstruktur

### Rechtlicher Hinweis zur Preisanpassung:

*Ein zentrales strategisches Hindernis in der Monetarisierung ist die juristische Lage bestehender SaaS-Verträge. Preisanpassungen bei Bestandskunden sind in Deutschland rechtlich nur zulässig, wenn entsprechende Preisanpassungsklauseln im ursprünglichen Vertrag oder in den AGB enthalten sind. Andernfalls ist eine nachträgliche Preiserhöhung einseitig nicht durchsetzbar – es sei denn, es erfolgt eine Kündigung des bestehenden Vertrags mit einem neuen Angebot. Dies bedeutet: Für Bestandskund:innen ohne solche Klauseln bleibt das aktuelle Preismodell bestehen, solange sie aktiv sind. Umso wichtiger ist es, neue Preislogiken über Produktneueinführungen (z. B. Plattform 2.0) und modulbasierte Upgrades abzubilden.*

SimpliMed betreut derzeit rund 3.980 aktive Kund:innen. Darüber hinaus existiert ein historischer Verteiler mit über 8.000 Kontakten – ein wertvoller Pool für Reaktivierungs- und Upselling-Maßnahmen.

Die Preisstruktur ist historisch gewachsen und heterogen. Online-Kunden zahlen je nach Einstiegszeitpunkt zwischen EUR 19,99 und EUR 98,98 monatlich. Eine systematische Anpassung der Bestandskundenpreise ist bislang unterblieben – aus Rücksicht auf langjährige Verträge und rechtliche Beratung. Neue Kunden werden hingegen zu aktualisierten Tarifen geführt.

Rund die Hälfte der Kundenbasis basiert auf einem Offline-Kaufmodell. Hier wurden einmalige Preise zwischen EUR 398,99 und EUR 798,98 aufgerufen. Diese Kundengruppe ist schwerer zu reaktivieren, bietet aber bei Umstellung auf die Online-Plattform ein erhebliches Potenzial für Cross-Selling und modulbasiertes Upselling.

Demografisch dominiert der Heilpraktiker-Sektor mit ca. 88 % Marktanteil. Weitere Zielgruppen sind Privatärzt:innen (8 %), Physiotherapeut:innen (3 %) und vereinzelt andere Berufsgruppen wie Tierärzt:innen oder Hebammen (1 %).

## 2.4 Strategische Ableitungen:

1. Zielgruppenschärfung: Der Fokus liegt bisher auf Heilpraktiker:innen. Perspektivisch sollten jedoch auch Privatärzt:innen gezielter angesprochen werden – insbesondere durch die Integration verkaufsnaher Zusatzangebote wie NutriShop24, die sich auch für Ärzt:innen wirtschaftlich interessant vermarkten lassen.
2. Segmentierung: Trennung zwischen aktiven Online-Nutzern, reaktivierbaren Offline-Kunden und potenziellen Neukunden.



3. Preismodell-Modernisierung: Einführung eines dynamischeren, modifizierbaren Lizenzmodells mit transparenter Upgrade-Logik.
4. Wertschöpfung aus Bestand: Reaktivierung über Fortbildungsangebote, Onboarding, neues Preismodell und gezielte Ansprache.
5. Pflege der Nebengewerbe-Kunden: Die Multimandantenfunktion wird vielfach zum Vertrieb von Gesundheitsprodukten genutzt – ein strategisches Argument für NutriShop-Integration.  
Das Produkt hat funktionale Stärke, aber strategische Streuung. Der neue Fokus muss lauten: Systematisierung vor Expansion.

## **2.5 Produktbestand & Marktwirkung**

Das aktuelle Produkt ist in seinen funktionalen Kernen (Kundenverwaltung, Rechnungsstellung, Dokumentenmodul) sehr ausgereift. Gleichzeitig erschwert die Vielfalt an Funktionen ohne klare Struktur die Skalierbarkeit, Verständlichkeit und Weiterentwicklung.

Bestandskunden sehen SimpliMed nicht als Innovationstreiber, sondern als stabiles Handwerkstool. Kündigungsraten sind niedrig, doch neue Kunden werden kaum noch erschlossen. Die große Herausforderung besteht darin, die bestehende Nutzerbasis auf ein neues Lizenz- und Technologiemodell zu überführen.

## **2.6 Nutzungsmuster**

Die typischen Nutzer:innen sind Heilpraktiker:innen, Privatärzt:innen oder Therapeuten mit Selbstzahlerbezug. Die meisten nutzen lediglich den administrativen Kern (Kundenakte, Rechnung, Kalender). Zusatzfunktionen wie Newsletter, Videosprechstunde oder Produktanbindung (z. B. Nahrungsergänzung) werden kaum verwendet – weil sie entweder unbekannt oder schwer zugänglich sind.

Das lässt vermuten: Das System ist überfrachtet – und untervermarktet.

## **2.7 Technologisches Fundament**

Die Softwarearchitektur basiert auf einem veralteten Stack, der nur eingeschränkt modularisierbar ist. Ein Plattformwechsel ist notwendig, um:

- API-Schnittstellen zu Drittanbietern zu öffnen (Shop, Fortbildungen)
- mobile Nutzung zu vereinfachen
- Oberflächen zu vereinheitlichen
- neue Module nach Bedarf einspielbar zu machen (Store-Logik)



### 3. Strategisches Zielbild (2025–2027)

Aufbauend auf der Analyse ergibt sich ein klares Zukunftsbild: SimpliMed soll nicht nur technologisch modernisiert, sondern auch strategisch neu aufgestellt werden. Dieses Zielbild definiert, welche Rolle die Plattform in Zukunft spielen soll, welche Kundensegmente sie adressiert und wie sich daraus eine skalierbare Umsatzlogik ableiten lässt.

#### Plattformvision:

SimpliMed wird zur modularen SaaS-Plattform mit folgenden Prinzipien:

- Einfache Einstiegslösung (Kernmodul)
- Optional aktivierbare Zusatzmodule (per Klick buchbar)
- Monetarisierbare Partnerschaften (z. B. NutriShop24)
- Fortbildungs- und Lernbereiche zur Kundenbindung

#### Zielzahlen 2027:

| Metrik              | Zielwert          |
|---------------------|-------------------|
| Aktive Nutzer:innen | 10.000 TH         |
| Monatlicher ARPU    | 69 €              |
| Anteil Modulnutzer  | >65 %             |
| NutriShop-Anbindung | 750 aktive Praxen |

Diese Zahlen führen zu einem potenziellen Jahresumsatz von >8 Mio. € im Kernsystem plus Zusatzumsätze aus Modulen und Provisionen.





## 4. Produktarchitektur & Monetarisierung

SimpliMed wird künftig in eine klare Produktstruktur überführt, die eine einfache Einstiegslösung mit gezielt zubuchbaren Modulen kombiniert – technisch und vertrieblich konsequent getrennt.

### 4.1 Basismodul

Das neue Basismodul bildet die Grundlage für alle Nutzer:innen und umfasst folgende Bestandteile:

- Zentrales Dashboard mit Kontaktverwaltung, Dokumentenmanagement und Terminplanung (ohne Online-Terminbuchung)
- Administrativer Bereich (Praxisstammdaten, Ansprechpartner, Bankverbindung)
- Kommunikationskanal (Infobereich mit Bedienungsanleitungen, Modulübersicht, Fortbildungshinweisen und perspektivisch Werbung für Fachangebote)

#### Preisstruktur:

- Einzellizenz: **69 €/Monat**
- Teamlizenz (Multiuser): **99 €/Monat**

### 4.2 Hinzu buchbare Erweiterungsmodule

Die folgenden Module sind optional aktivierbar und werden monatlich berechnet:

- **Fakturierung 1:** Rechnungsstellung (19 €/Monat)
- **Fakturierung 2:** Erweiterung um Mahnwesen und Kontoumsätze (+9 €/Monat zusätzlich zu Fakturierung 1)
- **Online-Terminbuchung (Patientenseite):** 19 €/Monat
- **NutriShop-Integration:** Derzeit kalkuliert mit 29 €/Monat (vorbehaltlich finaler Verhandlung)
- **Zukunftsmodule (in Diskussion):**
  - Videosprechstunde (über Drittanbieter)
  - Laborschnittstelle (LDT)
  - Privatabrechnung mit Drittanbieter PVS

Diese Struktur sorgt für Übersichtlichkeit, flexible Anpassbarkeit an Praxisbedürfnisse und eine transparente Monetarisierung. Insbesondere das neue Dashboard fungiert als **Schaltzentrale für Aktivierung, Steuerung und Kundenkommunikation.**



### 4.3 Migration & Preismodell für Bestandskund:innen

Die geplante Umstellung auf das neue System geht realistisch mit einem erwartbaren Abgang von rund 25 % **der Altkunden** einher. Diese kalkulierte Fluktuation basiert auf Erfahrungen aus ähnlichen Transformationsprojekten und betrifft vor allem preissensitive oder technikferne Nutzer:innen.

Ein zentrales Hindernis für viele Praxisinhaber:innen ist der grundsätzliche Aufwand eines Softwarewechsels: Datenmigration, Neulernen von Oberflächen, Unsicherheit im Praxisalltag. Diese Wechselbarriere wirkt besonders stark bei langjährigen Nutzer:innen, die mit bestehenden Prozessen vertraut sind – selbst wenn diese technisch überholt sind.

Der Effekt kann durch folgende Maßnahmen abgefedert werden:

- Klar kommunizierter Mehrwert durch das neue System
- Preislich attraktive Einführungsangebote für Bestand
- Technischer Migrationsservice mit Begleitung
- Fortbildungen zur Aktivierung bislang nicht genutzter Funktionen

Das neue Preismodell sorgt nicht nur für höhere Transparenz und Skalierbarkeit, sondern bringt SimpliMed in die Position, das Plattformpotenzial über neue Zielgruppen und Partnerangebote voll auszuschöpfen.

### 4.4 Patientenservices (perspektivisch)

Der Bereich der Patientenservices stellt für SimpliMed eine strategische Erweiterung dar, die zwar optional ist, aber erhebliche Bindungspotenziale bietet – sowohl für Therapeut:innen als auch für Patient:innen. Dabei geht es nicht um eine Konkurrenz zu umfassenden Patientenplattformen wie Doctolib, sondern um eine funktionale Ergänzung mit Fokus auf die Praxisrealität.

Im Kern geht es darum, die Patientenkommunikation zu professionalisieren und gleichzeitig die internen Prozesse in den Praxen zu entlasten. Ein zentrales Element sind digitale Anamneseformulare, die Patient:innen bereits vor dem Praxisbesuch online ausfüllen. Damit diese jedoch echten Mehrwert liefern, müssen sie eingebettet sein in eine vollständige Kommunikationsstrecke: automatisierte E-Mail-Erinnerungen, strukturierte Onboarding-Strecken und eventuelle Nachsorge-Logiken. Nur so entsteht eine durchgängige Patientenreise – und damit auch ein realistischer Nutzen für die Praxis. Das bedeutet aber auch eine umgesetzte Strecke innerhalb der Praxis.

### 4.4 Monetarisierungswege Nutrishop (*to be discussed*)

- NutriShop-Modell: Zwei Szenarien:
  - **SaaS-Modell:** SimpliMed bleibt technischer Integrator. Monatliche Gebühren gemäß NutriShop-Tarifmodell (ab 49 €/Monat), die vollständig an NutriShop24 gehen. Bei Umsatzbefreiung (ab 10.000 € Umsatz/Monat) zahlt NutriShop eine Plattformgebühr an SimpliMed.



- **Fulfillment-Modell:** SimpliMed übernimmt zusätzlich Teile des operativen Fulfillments (z. B. Kundensupport, Shopverwaltung). In diesem Fall erhält SimpliMed einen Anteil an den 10 % Provision.

#### 4.5 Zukunftsperspektiven & Markttrends

Die Weiterentwicklung von SimpliMed muss sich an den fundamentalen Umbrüchen im Gesundheitsmarkt orientieren – sowohl regulatorisch als auch technologisch. Ein zentraler Impuls kommt durch die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA), die ab Januar 2025 verpflichtend für alle gesetzlich Versicherten eingeführt wird. Softwareanbieter, die keine Schnittstellen zu ePA und E-Rezept-Systemen anbieten, laufen Gefahr, regulatorisch und funktional abgehängt zu werden.

Ein weiteres Megathema ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die medizinische Praxis. KI-gestützte Funktionen – etwa für die automatisierte Anamnese, Terminsteuerung oder sogar Diagnostikassistenz – gewinnen zunehmend an Relevanz. Auch kleinere Anbieter wie SimpliMed sollten mittelfristig KI-Module evaluieren, um administrative Abläufe zu optimieren und ihre Attraktivität für neue Nutzergruppen zu steigern.

Telemedizin wird nicht mehr nur als Notlösung gesehen, sondern ist fester Bestandteil einer hybriden Versorgungskette. Die Möglichkeit, sichere Videoberatungstools sowie Fernüberwachungsfunktionen (z. B. über Wearables) zu integrieren, wird von modernen Praxissoftwares erwartet. Patienten wollen orts- und zeitunabhängig kommunizieren können – auch dies muss Teil eines modularen Angebots werden.

Darüber hinaus verändert sich der Markt der Praxissoftwareanbieter. Während große Player wie Doctolib durch Terminbuchungssysteme und Patientenportale dominieren, positionieren sich Anbieter wie Tomedo durch KI-Funktionen und Medistar durch Systemoffenheit. SimpliMed hat die Chance, sich durch seine Spezialisierung auf Selbstzahlerleistungen, eine klare Add-on-Strategie und praxisorientierte Fortbildungsintegration als Nischenführer neu zu etablieren.

#### 4.6 Zentrales Therapeut:innen-Dashboard – der strategische Zugangspunkt

Ein zentrales Element der neuen Plattformstrategie ist der Aufbau eines **Therapeut:innen-Dashboards**, das alle Nutzer:innen an einem einzigen Ort bündelt – technisch wie inhaltlich. Dieses Dashboard soll künftig nicht nur die administrative Steuerung ermöglichen, sondern auch als **zentraler Hub für Kommunikation, Funktionserweiterung und Monetarisierung** dienen.

##### Funktionale Rolle

Im Zentrum steht ein personalisierter Zugang für jede Praxis – analog zu einem „Cockpit“ – über das sowohl administrative als auch geschäftliche Funktionen zugänglich sind. Dazu zählen:

- **Kommunikationszentrum:** Systemnachrichten, Hinweise auf neue Module, Updates, personalisierte Hinweise (z. B. Feature noch nicht aktiviert).



- **Modulmanagement:** Übersicht aller aktiven Module, einfache Buchung zusätzlicher Funktionen (One-Click-Upsell), Kündigung/Wechsel.
- **Nutzerprofil & Abrechnung:** Zugang zu Verträgen, Rechnungen, Lizenzverlauf, Zahlungsinformationen.
- **Werbeintegration:** Kontextuelle Hinweise auf relevante Drittangebote – etwa Fortbildungen, Fachprodukte oder Praxislösungen. Die Platzierung erfolgt dezent, themenspezifisch und **ohne Tracking**.

## Monetarisierungspotenziale

Dieses Dashboard ist auch der strukturelle Anker für Zusatzumsätze:

- **Modularisierung aktivieren:** Sichtbarkeit ist der Schlüssel – wer Features nicht kennt, kann sie nicht nutzen.
- **Drittintegration (NutriShop etc.) fördern:** Durch Sichtbarkeit und kuratierte Empfehlungen.
- **Kontextbasierte Werbung ermöglichen:** z. B. Einblendungen zu neuen Fortbildungen oder White-Label-Produkten im Bereich Labor, Diagnostik oder Supplements – **exklusiv für Behandler:innen**.

## Langfristige Perspektive: Patienten-Dashboard (optional)

Parallel sollte geprüft werden, ob eine spätere Öffnung in Richtung Patient:innen sinnvoll ist. Denkbar wäre ein **gespiegelter Zugang** für Endnutzer:innen, in dem folgende Inhalte bereitgestellt werden:

- Zugriff auf Rechnungen (PDF-Download)
- Bezahlungsmöglichkeit
- Einsicht in Befunde oder Therapiepläne (PDF)
- Terminübersicht (rein lesend)
- Wiedervorlagen, Erinnerungen

Diese Lösung hätte hohen Komfortwert – vor allem im Kontext moderner Selbstzahlerpraxen. Allerdings muss berücksichtigt werden:

- **Rechtliche Sensibilität** (Datenschutz, DSGVO)
- **Medizinisch-ethische Dimensionen** (Diagnosen ohne direkte Begleitung)
- **Kommerzielle Grenzen:** Werbung innerhalb eines Patientenzugangs wäre **problematisch**, insbesondere im sensiblen Bereich Gesundheit. Hier gilt ein besonders hoher regulatorischer und ethischer Standard.

## Fazit



Das Therapeut:innen-Dashboard ist der erste konkrete Ausdruck einer Plattformlogik, die Funktionalität, Monetarisierung und Nutzerbindung an einem zentralen Ort vereint. Es strukturiert die gesamte User Experience: vom Basiszugang über die Aktivierung zusätzlicher Module bis hin zu gezielten Kommunikationsimpulsen. Damit ersetzt es das bisher fragmentierte Nutzungserlebnis durch ein zukunftsfähiges, wachstumsorientiertes Interface.

Die Monetarisierung über Drittangebote, Fortbildungen und Shopanbindungen lässt sich über das Dashboard systematisch aktivieren – ohne invasive Werbung, aber mit relevanter Sichtbarkeit. Auch qualitative Auswertungen (z. B. welche Module werden wie stark genutzt?) können von hier aus gesteuert und analysiert werden.

**Hinzu kommt ein zusätzlicher ökonomischer Aspekt:** Sobald das Dashboard in der Breite genutzt wird, eröffnet es Möglichkeiten für **qualifizierte Fachwerbung** – etwa für Fortbildungen, Praxisbedarf oder digitale Gesundheitsservices. Diese Inhalte können kontextsensitiv eingebunden werden (z. B. im Modulbereich, in Mitteilungen oder Empfehlungen) und generieren werthaltige Reichweite ohne algorithmische oder datenschutzrechtliche Risiken.

Gleichzeitig bildet das Dashboard das Fundament für eine mögliche zweite Ausbaustufe: einen kontrollierten Zugang für Patient:innen. Dieser sollte jedoch mit maximaler Sorgfalt geplant werden. Medizinische, datenschutzrechtliche und ethische Standards sind hier besonders hoch. Werbung oder produktbasierte Hinweise im Patientenkontext wären kritisch – sowohl regulatorisch als auch reputationsseitig – und sollten daher ausgeschlossen bleiben.

**Fazit:** Zuerst die Therapeut:innen gewinnen, aktivieren und monetarisieren – über ein Dashboard, das als Schaltzentrale dient. Erst danach kann – auf Basis realer Nutzung und Vertrauensaufbau – geprüft werden, ob ein Patient:innenbereich sinnvoll und vertretbar ist. Werbung bleibt dabei kein Kernmodell, aber ein **gezielter Hebel für Mehrwertangebote im Fachkontext**.



## 5. Markt & Wettbewerb

Der Markt für medizinische Praxissoftware in Deutschland wird dominiert von wenigen großen Anbietern mit starker Kapitalisierung und aggressivem Marketing. Plattformen wie Doctolib haben durch ihre breite Terminvermittlungslogik und patientenseitige Sichtbarkeit eine hohe Marktpräsenz aufgebaut. Andere Anbieter wie Tomedo oder Medistar setzen auf modulare Softwarestrukturen, integrierte KI-Elemente oder spezifische Integrationsfähigkeit mit klinischen IT-Systemen.

SimpliMed agiert in einem anderen Segment: Selbstzahlermedizin, Heilpraktik, privatärztliche Therapien und alternative Gesundheitsangebote. Dieser Bereich ist bislang digital unterversorgt, jedoch zunehmend relevant, weil immer mehr Patient:innen gezielt Zusatzleistungen nachfragen, die nicht über die GKV abgewickelt werden können. Genau hier liegt das Differenzierungspotenzial.

Anstatt sich mit universellen Plattformen zu messen, sollte SimpliMed sich als Spezialanbieter für administrative Exzellenz im Selbstzahlermarkt positionieren – mit Expertise in Abrechnung, Therapiedokumentation, Patientenkommunikation und Integration verkaufsnaher Module wie NutriShop.

Diese Differenzierung über Fachlichkeit, Modularität und Zusatzumsätze bildet die Grundlage für ein nachhaltiges Marktprofil. In der Logik: Nicht größer – sondern gezielter. Nicht breiter – sondern spezialisierter. Und nicht lauter – sondern wirksamer.

### 5.1 SoliPrax – Niedrigpreismodell mit versteckten Kosten

SoliPrax verfolgt ein Offline-Modell mit extrem günstigen Einstiegspreisen:

- Basisprogramm: 10 €/Jahr
- Erweiterungsmodule: 15–65 €/Jahr
- Buchhaltung: 34,50 €/Jahr
- Abrechnungsgebühr: 4,5 % (!) des Fakturavolumens
- Werbung: Wird in der Software eingeblendet

**Bewertung:** SoliPrax wirkt auf den ersten Blick günstig, belastet Praxen jedoch indirekt über variable Transaktionskosten und Werbeeinspielungen. Die technische Architektur ist veraltet, eine Cloud- oder API-Nutzung nicht möglich. Für qualitätsorientierte, wachsende Praxen ist das Modell kaum tragfähig.

### 5.2 Lemniscus – Cloudlösung mit Limitierungen

Lemniscus bietet eine skalierbare Cloudlösung mit abgestufter Preislogik:

- Preise: 17 € bis 100 €/Monat je nach Terminvolumen und Nutzeranzahl
- Zusatzkosten: Für Speicher, SMS, Buchhaltung etc.
- Limitierungen: Nur 50 Sendungen, 5 Aktenmerkmale etc. – selbst in höheren Tarifen



**Bewertung:** Hinter einer flexiblen Fassade verbergen sich zahlreiche Einschränkungen und Zusatzkosten, die bei aktiver Nutzung überraschend ins Gewicht fallen. Für technologieaffine Praxen mit Integrationsbedarf fehlt eine moderne API- oder Dashboard-Logik. SimpliMed punktet hier mit Klarheit und ohne künstliche Schranken.

### 5.3 thevea – Spezialisierung auf Heilmittelerbringer

thevea fokussiert sich auf Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie:

- Starterversion: 29,90 €/Monat
- Pro-Version: 49,90 €/Monat
- Benutzerzugänge: 9,90 €/Monat
- Abrechnungsservice: 0,99 % des Umsatzes

**Bewertung:** thevea ist intuitiv, modern und branchenspezifisch – aber nicht auf Heilpraktiker:innen oder ärztliche Selbstzahler fokussiert. Die Abgrenzung zu SimpliMed liegt im Zielgruppenfokus und der geringeren Offenheit für Drittintegration oder Add-on-Vermarktung.

### 5.4 tomedo® – Apple-only Powerlösung

tomedo® ist eine umfassende, KI-gestützte Lösung für ärztliche Praxen mit Apple-Hardware:

- Preis: individuell, modular aufgebaut
- Funktionen: KI-Abrechnung, iPad-Dokumentation, GDT-Anbindung, Videosprechstunde
- Plattform: ausschließliche Nutzung auf Apple-Geräten

**Bewertung:** tomedo® ist technologisch stark, aber durch die Apple-Exklusivität eingeschränkt skalierbar. SimpliMed bietet eine systemoffene, browserbasierte Lösung mit gezielter Modularität und einfacher Einstiegshürde – vor allem für nicht-ärztliche Berufe und Selbstzahlerpraxen ein entscheidender Vorteil.

### Fazit: Differenzierung durch Fokus, Technologie und Monetarisierbarkeit

SimpliMed grenzt sich durch folgende Merkmale klar vom Wettbewerb ab:

- **Modularität ohne Limitierungen**
- **Plattformunabhängige Cloudarchitektur (Headless, API-first)**
- **Zielgruppe: Selbstzahler & alternative Heilberufe**
- **Dashboard-basierte Steuerung & Upselling**
- **Keine Werbung, keine Transaktionsgebühren**

Damit positioniert sich SimpliMed als technologisch fokussierter Spezialist mit klarem Mehrwert gegenüber volumengetriebenen Generalisten.







## 6. Produktentwicklung & Technologiekonzept

Der technologische Umbau von SimpliMed verlangt nach mehr als einem UI-Refresh – er erfordert eine Neustrukturierung des gesamten digitalen Fundaments. Die Plattform der Zukunft basiert nicht mehr auf monolithischen Architekturen, sondern auf modularen Systemen mit klar definierten Schnittstellen, austauschbaren Komponenten und einer serviceorientierten Logik.

Im Kern steht der Wechsel zu einer Headless-Struktur mit einem React-Frontend und Microservices-Logik im Backend. Diese Architektur erlaubt maximale Skalierbarkeit, eine gezielte API-Steuerung und die Entwicklung separater Module, die unabhängig voneinander deployed und weiterentwickelt werden können.

Ergänzt wird diese Infrastruktur durch ein API-Gateway, das Drittanbieter nahtlos integrierbar macht – von Fortbildungsplattformen bis zu E-Commerce-Anbindungen wie NutriShop24. Der Betrieb erfolgt vollständig cloudbasiert, mit Datenhaltung in Deutschland und DSGVO-konformer Verschlüsselung.

Die Implementierung folgt einer klaren Roll-out-Logik: Beginnend mit einem MVP bestehend aus drei Kernmodulen (Rechnung, Kundenakte, Kalender) und einem exemplarischen Zusatzmodul (z. B. Newsletter), wird die Plattform zunächst in einem Pilotcluster mit ausgewählten Bestandskunden getestet. Erst nach iterativer Verfeinerung erfolgt die Öffnung auf breiterer Basis – bevorzugt für Kunden, die bisher mit der Offline-Version arbeiten.



## **7. Unique Selling Propositions (USP) – Was SimpliMed einzigartig macht**

### **7.1 Abrechnungs-Expertise: Mehr als nur Software**

SimpliMed ist mehr als ein digitales Werkzeug – es ist ein Abrechnungsprofi mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Seit 1998 am Markt, genießt das Unternehmen einen exzellenten Ruf unter Heilpraktiker:innen, Selbstzahlerpraxen und Privatärzt:innen.

SimpliMed maximiert Praxiseinnahmen – weil es genau weiß, wie man korrekt, vollständig und wirtschaftlich abrechnet.

Die Software ist nicht nur technisch auf GOÄ, GebÜH und BBhV abgestimmt, sondern bietet auch viele Spezialfunktionen für effiziente Faktura: Mahnwesen, Rezeptlogiken, Honorardefinitionen und Zahlungserinnerungen sind präzise auf die Praxisrealität zugeschnitten. Dies senkt Ausfallquoten, erhöht den Abrechnungserfolg – und stärkt das Vertrauen der Nutzer:innen. Dieses Vertrauenskapital ist ein entscheidender USP in einem fragmentierten Markt mit vielen Schnellgründungen ohne Branchenverständnis.

### **7.2 Monetarisierbare Plattform: Die erste Praxissoftware mit Zusatzumsatz**

Mit der Integration von NutriShop24 hebt SimpliMed das Modell „Praxissoftware“ auf eine neue wirtschaftliche Ebene. Anwender:innen können nicht nur effizient verwalten, sondern zusätzlich aktiv Einkommen generieren:

- Rechtssicherer Online-Praxisshop: Kein Lager, kein Personal, kein Versand – alles wird durch NutriShop24 organisiert.
- Minimale Einstiegshürde: Gewerbeanmeldung und Einrichtung sind in unter 3 Stunden erledigt.
- Volle Kontrolle über Produktportfolio: Therapeut:innen empfehlen nur, was sie für medizinisch sinnvoll halten.
- Attraktives Ertragsmodell: Ab 10.000 € Umsatz ist der Shop kostenfrei nutzbar. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei ca. 23 % (Beispielrechnung auf Seite 11 der NutriShop-Präsentation).
- Keine rechtlichen Hürden für Ärzte: Durch die digitale Trennung und externen Betrieb ist der Shop auch für Ärzt:innen 100 % berufsrechtskonform.

SimpliMed ist damit die erste Plattform, die Digitalkompetenz mit Praxisökonomie verbindet – ein echter Paradigmenwechsel für viele Therapeut:innen.

### **10.3 Technologieplattform mit Zukunftslogik**

SimpliMed wird zu einer Headless-, API-first-Plattform, die durch ein zentrales Dashboard steuerbar ist. Dies ermöglicht:

- Nahtlose Integration externer Partner (Shops, Fortbildungen, Labore etc.)
- Skalierbarkeit durch modulare Architektur
- Individuelle Erweiterbarkeit je nach Praxisbedarf
- Datenhaltung in Deutschland, vollständig DSGVO-konform



#### **7.4 Zielgruppenspezialisierung statt Massenansprache**

Im Unterschied zu Generalisten wie Doctolib oder Tomedo konzentriert sich SimpliMed auf alternative Heilberufe und Selbstzahlerpraxen. Dieses Segment ist kaufkräftig, unterdigitalisiert – und sucht nach spezialisierten Lösungen. Die tiefe Kenntnis der AbrechnungsCodes, rechtlichen Anforderungen und Marktgepflogenheiten verschafft SimpliMed einen Fokusvorsprung mit hoher Relevanz.

Fazit: SimpliMed kombiniert tiefes Branchenwissen, technische Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Hebelwirkung in einer einzigen Plattform. Die Positionierung lautet: „Software, die versteht, wie Praxis wirklich funktioniert – und wie daraus echte Wertschöpfung wird.“



## 8. Marketing & Vertrieb: Migration, Reaktivierung und digitales Wachstum

Für die erfolgreiche Skalierung von SimpliMed ist ein integrativer Ansatz aus Vertrieb und Marketing entscheidend. Dabei geht es nicht nur darum, neue Kund:innen zu gewinnen, sondern vor allem um die **Aktivierung, Migration und Reaktivierung bestehender Gruppen**, gepaart mit einem modernen Markenauftritt und gezielten Co-Marketing-Initiativen.

### 8.1 Migration der bestehenden Online-Kund:innen

Die rund 3.980 aktiven Online-Nutzer:innen stellen die tragende Säule der Bestandsbasis dar – und gleichzeitig das größte Potenzial für eine **kurzfristige Umsatzsteigerung durch Systemwechsel**. Ziel ist es, diese Nutzer:innen schrittweise und begleitet auf das neue modulare System zu migrieren.

#### Maßnahmen:

- **Nutzerzentrierte Kommunikation:** Betonung auf einfache Bedienung, neue Funktionen, wirtschaftlicher Nutzen (z. B. NutriShop).
- **Technisch begleitete Migration:** Supportgesteuerte Umstellung mit Datenübernahme und persönlicher Begleitung.
- **Zeitlich befristete Angebote:** Vergünstigte Module oder Freimonate bei zeitnaher Umstellung.
- **Onboarding-Fortbildungen:** Schulungen zur Nutzung neuer Features – auch als Upselling-Instrument.

### 8.2 Reaktivierung der Offline-Nutzer:innen

Ein noch weitgehend unerschlossenes Potenzial liegt in der **Offline-Kundengruppe**, die in der Vergangenheit Einmalversionen erworben hat. Da keine technische Rückmeldung erfolgt, ist nicht bekannt, welche dieser Praxen noch aktiv sind. Hier ist ein systematisches Reaktivierungsprogramm nötig.

#### Maßnahmen:

- **Kundenidentifikation:**
  - E-Mail- und Briefmailing-Kampagnen mit Reaktivierungsangebot
  - Stichprobenhafte Telefonaktionen zur Qualifizierung
  - Landingpage „Zurück zu SimpliMed“ mit Call-to-Action
- **Konvertierungsprogramm:**
  - Kostenloser Probemonat der Online-Version
  - Highlighting moderner Features (mobil, nutzerfreundlich, abrechnungssicher)
  - Storytelling: „Das System, das Sie kennen – in neuer Exzellenz.“



### 8.3 Digitales Marketing & strategische Co-Partnerschaften

SimpliMed wird sich künftig auch als **digitale Marke mit klarer Expertenpositionierung** positionieren – insbesondere im Selbstzahler- und Heilpraktikmarkt. Ziel ist es, sowohl Sichtbarkeit als auch Vertrauen und Leads über digitale Kanäle zu generieren.

#### Maßnahmen:

- **Social Media Positionierung:**
  - LinkedIn-Content zu Abrechnung, Digitalisierung, Selbstzahlertrends
  - Instagram-Kampagnen mit Testimonial-Stories, Micro-Videos
- **Content Marketing:**
  - Fachartikel, Whitepapers, Abrechnungs-Guides mit Lead-Gewinnung
  - Fortbildungsangebote zu neuen Modulen
- **Co-Marketing mit NutriShop-Herstellern:**
  - Gemeinsame Webinare oder Produktaktionen
  - Shop-Guthaben oder Promotions für Neukunden
- **Partnerschaften mit Fortbildungsplattformen:**
  - Integration von SimpliMed als Fortbildungsplattform
  - Crosslinks, Co-Branded Mailings und Bundles

**Vertriebsseitig** wird dies ergänzt durch:

- Aufbau eines **Customer Success Teams** mit klarer Conversion- und Upselling-Mission
- Entwicklung von **Vertriebsunterlagen & Schulungsmaterialien** für die Modularchitektur
- Einführung eines **CRM-gestützten Vertriebsprozesses** zur strukturierten Zielgruppenansprache

**Fazit:** Marketing und Vertrieb bilden künftig eine strategische Einheit – mit dem Ziel, bestehende Potenziale systematisch zu heben und neue Praxen über einen klaren, digitalen Markenkern zu gewinnen. Dabei stehen **Praxisnutzen, Vertrauen und ökonomischer Mehrwert** im Vordergrund – nicht technologische Spielerei.



## 9. Businessplan & Investorenstrategie

### 9.1 Personal IST-Stand

#### A. Technologischer Plattformwechsel (Kapitel 4 & 6)

**Aufwand:** Hoch (Microservices, Headless, React, API-Gateway, MVP-Rollout)

**Ressourcen im Team:** 1 externer Entwickler + 1 externer Designer/AI

**Risiko:** Extrem knapp. Für einen vollständigen Replatforming-Prozess sind mindestens 2–3 FTEs (intern oder projektbasiert) in Frontend/Backend/DevOps nötig.

#### B. Kundenmigration & Support (Kapitel 4.3, 8.1)

**Aufwand:** Mittel bis hoch (Bestandskommunikation, Datenübernahme, Onboarding)

**Ressourcen im Team:** 3 Mitarbeitende in Support/Schulung + Callcenter

**Risiko:** Schaffbar bei guter Prozessautomatisierung – aber nur bei geringer zusätzlicher Belastung (keine aggressive Skalierung oder Neukundenzugänge parallel).

#### C. Marketing & Vertrieb (Kapitel 8)

**Aufwand:** Mittel bis hoch (Co-Marketing, Social Media, Content, Lead Scoring, CRM, Landingpages)

**Ressourcen im Team:** 1 Person Social Media + evtl. Callcenter

**Risiko:** Unterbesetzt. Es fehlen klar definierte Rollen für Content Creation, Performance Marketing, CRM/Automation.

#### D. Produktentwicklung & UX (Kapitel 4.1–4.2, 6)

**Aufwand:** Hoch (Modularisierung, Pricing-Logik, Dashboards)

**Ressourcen im Team:** Nur teilweise durch CEO und Designer abgedeckt

**Risiko:** Ohne dediziertes Product Management oder UX/PM-Rolle wird es schwierig, die neue Plattform logisch und nutzerzentriert aufzubauen.

**Fazit:** Teils realisierbar, teils unterbesetzt

**Was möglich ist mit aktuellem Team:**

- Migration einzelner Bestandskunden
- Unterstützung durch Schulungsteam & Callcenter
- Fortsetzung von „Privatabrechnung24“
- Kleinere UI/UX-Anpassungen durch externen Designer

**Was kritisch ist oder fehlt:**

- Plattformumbau in React/API-first → zu wenig Dev-Ressourcen
- Skalierbarer Vertrieb + digitales Marketing → unbesetzt
- Produktstrategie & Projektsteuerung → keine dedizierte Rolle
- Investorenkommunikation & Controlling → nicht sichtbar



## 9.2 Empfohlene Personalergränzungen (für 12–18 Monate Umsetzungszeitraum)

| Rolle                              | Aufgabenbereich                                                    | Bedarf  | Ø Jahresgehalt brutto (inkl. Lohnnebenkosten) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Lead Developer (Fullstack)         | Aufbau der neuen SaaS-Architektur (React, API, Cloud), Teamführung | 1 FTE   | ca. 100.000 €                                 |
| Frontend Developer                 | UX, React, UI-Komponenten, Dashboard                               | 1 FTE   | ca. 75.000 €                                  |
| Backend Developer                  | API, Datenlogik, Datenbankankbindung, Nutzerverwaltung             | 1 FTE   | ca. 75.000 €                                  |
| Product Owner / Projektmanager     | Modulspezifikation, Roadmap, Testing, Abstimmung mit Stakeholdern  | 1 FTE   | ca. 85.000 €                                  |
| Digital Marketing Manager          | Social Media, Kampagnen, Lead Nurturing, Performanceanalyse        | 1 FTE   | ca. 65.000 €                                  |
| Content Creator (Teilzeit möglich) | Whitepapers, Video-Tutorials, Fortbildungsinhalte, LinkedIn        | 0.5 FTE | ca. 30.000 €                                  |
| Customer Success Manager           | Onboarding, Upselling, Zufriedenheitsmanagement                    | 1 FTE   | ca. 60.000 €                                  |
| Sales Manager (B2B SaaS)           | Konvertierung von Offline-Kunden, Partnerakquise                   | 1 FTE   | ca. 70.000 €                                  |

## 9.3 Abgleich empfohlene Rollen vs. bestehendes Organigramm

| Empfohlene Rolle          | Im Organigramm vorhanden?  | Anmerkung zur Realität                                                         |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lead Developer            | 1x „Developer (extern)“    | vorhanden, aber keine Teamführung oder Skalierung vorgesehen                   |
| Frontend Developer        | ✗ nicht explizit           | Nur generalistisch angedeutet durch „externer Entwickler“                      |
| Backend Developer         | ✗ nicht genannt            | API & Architektur fehlen im Skillset laut Aufstellung                          |
| Product Owner / PM        | ✗ nicht vorhanden          | Zentrale Rolle zur Steuerung fehlt                                             |
| Digital Marketing Manager | 1x „Social Media“ (intern) | vorhanden, aber nicht strategisch – kein Performance, CRM oder Funnel-Know-how |
| Content Creator           | ✗ nicht aufgeführt         | Wird evtl. punktuell abgedeckt (unklar)                                        |



| Empfohlene Rolle         | Im Organigramm vorhanden? | Anmerkung zur Realität                                                       |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Customer Success Manager | 2x Support/Schulung       | Teils abgedeckt, aber ohne Vertriebsorientierung (Upselling, Lifetime Value) |
| Sales Manager (B2B SaaS) | ✗ nicht vorhanden         | Keine explizite Vertriebsrolle im SaaS-Kontext sichtbar                      |

#### Fazit:

- Rund 50 % der empfohlenen Rollen sind ansatzweise abgedeckt, aber mit eingeschränkter Kapazität, strategischer Tiefe oder fehlender Skalierbarkeit.
- Für den technischen Umbau und den marktorientierten Rollout sind zusätzliche Ressourcen zwingend notwendig – entweder intern neu aufgebaut oder extern über Agenturen/Freelancer eingebunden.

## 9.4 Kostenstruktur

### Operations

| Kostenblock                  | Fixkosten (jährlich) | Variable Kosten (%) | Kommentar |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Personal                     |                      | -                   |           |
| IT / Wartung                 |                      | -                   |           |
| Marketing & Vertrieb         |                      | 10 % des Umsatzes   |           |
| Sonstige betriebliche Kosten |                      | -                   |           |

*Details Exceltabelle)*

### Neu-Entwicklung, Deployment und Vertriebsaufbau

Software-Development

Marketing und Vertriebsaufbau

Gesamt

*Details Exceltabelle)*

**Diskussion: Gesamtbudget Personalaufbau (12 Monate) – falls nicht intern besetzt werden kann:**





ca. xxxx p.a. bei interner Besetzung aller Rollen.

Alternativen:

- Teilweise Umsetzung über Freelancer/Agenturen (z. B. UX, Content): teurer, aber schneller verfügbar.
- Aufsplitten in „technische Phase“ (Jahr 1) und „Skalierungsphase“ (ab Jahr 2).

## 9.5 Modellierter Umsatz- und Absatzentwicklung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die modellierte Entwicklung der Kundenbasis, differenziert in stabile Altkunden und moderat wachsende Neukunden, sowie die daraus resultierende Umsatzentwicklung über zwölf Monate hinweg. Zusätzlich werden die Erlöse aus einzelnen Zusatzmodulen separat ausgewiesen und zur Gesamtleistung aggregiert.

**Siehe Excel Tabelle**

## 9.6. Ausblick und Vision

## 9.7 Gesamtinvestition & Kapitalstrategie

Die wirtschaftliche Skalierung von SimpliMed stützt sich auf drei zentrale Umsatzsäulen: das monatliche Lizenzmodell, die Monetarisierung über Zusatzmodule sowie die Provisionierung integrierter Drittangebote wie NutriShop24. Ziel ist es, den durchschnittlichen Umsatz pro Therapeut:in (ARPU) auf mindestens 69 €/Monat zu heben und gleichzeitig die Aktivierungsquote relevanter Module signifikant zu steigern.

Für die Umsetzung dieser Neuausrichtung wird ein Initialkapital im mittleren sechsstelligen Bereich erforderlich sein. Dieses Investment deckt die vollständige technische Neuentwicklung der Plattform, UX-/UI-Redesign, begleitende Kommunikationsmaßnahmen zur Kundenmigration sowie einen operativen Kapitalpuffer für die ersten zwölf Monate nach dem Roll-out.

Darüber hinaus soll ein Teil der Mittel in den gezielten Aufbau eines Vertriebsteams fließen – mit Fokus auf Upselling bei Bestandskund:innen sowie der systematischen Konvertierung von Offline-Nutzer:innen auf die neue SaaS-Plattform. Begleitend entsteht ein Investoren-Pitch und eine fokussierte Roadshow zur Kapitalakquise – primär im Umfeld digitaler Gesundheitslösungen, aber auch im Bereich alternativer Heilmethoden, in dem SimpliMed inhaltlich verankert ist.

## 9.8 Offene Finanzierungsfrage: Investoren, Kredite oder Fördermittel?

Die zentrale Frage der Kapitalstrategie bleibt bewusst offen: Soll SimpliMed den Wandel durch externe Investor:innen finanzieren – mit entsprechendem Equity-Modell, Mitspracherechten und potenziellen Skalierungspartnerschaften? Oder ist eine konservativere Struktur denkbar – etwa über zinsgünstige Förderkredite (z. B. KfW, BAFA), Innovationsförderprogramme oder öffentliche Co-Finanzierung?

**Beide Modelle haben strategische Vor- und Nachteile:**



| Option               | Vorteile                                                                 | Herausforderungen                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Investorenmodell I   | Schneller Kapitalzugang, strategisches Netzwerk, mögliche Co-Vermarktung | Abgabe von Anteilen, Einfluss auf Unternehmensstrategie                        |
| Förder-/Kreditmodell | Kapital bleibt intern, mehr Entscheidungsfreiheit                        | Längere Beantragungsphasen, ggf. eingeschränkter Betrag. Keine Synergieeffekte |

Die Entscheidung über die Kapitalquelle sollte daher nicht nur finanzielle Kriterien berücksichtigen, sondern auch kulturelle und strategische: Wie viel Steuerung will SimpliMed behalten? Wie schnell muss das Wachstum erfolgen? Und in welchem Tempo soll sich die Organisation transformieren?

Im Zentrum steht nicht nur die Frage nach der Kapitalhöhe – sondern nach dem passenden Partner für die nächste Evolutionsstufe.



## 10. Kritische Erfolgsfaktoren & Handlungsempfehlungen

Die Umsetzung der neuen SimpliMed-Plattform steht und fällt mit der operativen Exzellenz in der Umsetzungsphase. Neben technischer Stabilität ist insbesondere die Nutzerführung entscheidend – denn Bestandskund:innen müssen nicht nur technisch migriert, sondern emotional überzeugt werden.

Die hohe Komplexität der bisherigen Software darf sich nicht in die neue Plattform fortschreiben. SimpliMed muss einfache, fokussierte Nutzeroberflächen bieten, klar strukturierte Upgradepfade und einen modularen Einstieg, der auch technikferne Nutzer:innen nicht überfordert.

Strategisch empfiehlt sich, mit einem scharf geschnittenen MVP zu starten und sich nicht im Wunsch nach Vollständigkeit zu verlieren. Die Kommunikation muss konsequent die Positionierung als „System für Selbstzahler:innen und alternative Heilberufe“ herausstellen – nicht als Konkurrenz zu klassischen Terminbuchungssystemen.

Darüber hinaus sollten neue Umsatzpfade wie NutriShop nicht nur technisch eingebunden, sondern auch kommunikativ inszeniert werden – etwa über Webinare, Fortbildungen oder gezielte Kampagnen. Die Marke SimpliMed wird nicht durch Reichweite, sondern durch Relevanz wachsen. Und diese entsteht nicht durch Software, sondern durch Lösungen, die echte Praxisprobleme lösen.



## 11. Gesamtfazit

SimpliMed steht am Wendepunkt: Vom bewährten Werkzeug für Selbstabrechnungspraxen hin zu einer modularen, skalierbaren Plattform für alternative Heilberufe. Die Analyse zeigt ein stabiles Fundament – hohe Kundenbindung, funktionale Tiefe und ein starkes Standing im Segment der Selbstzahlerleistungen. Doch dieses Potenzial ist bislang unterverwertet.

Die Neupositionierung baut auf vier strategischen Säulen:

1. Technologischer Neustart – eine neue Plattformarchitektur mit moderner UI, modularer Logik und klar definierten Integrationspunkten.
2. Produktfokus und Modularisierung – Konzentration auf hochrelevante Kernfunktionen und optionale Zusatzmodule mit echtem Mehrwert.
3. Monetarisierungsvielfalt – ein flexibles Erlösmodell aus Lizenzen, Modulen, Drittintegration (z. B. NutriShop) und künftig auch gezielter Fachwerbung.
4. Zentralisiertes Dashboard – als Interface für Steuerung, Upselling und Kommunikation mit Therapeut:innen, das mittelfristig auch für strategische Analysen und Angebotssteuerung genutzt werden kann.

Das Dashboard wird dabei nicht nur zum Vertriebs- und Steuerungsinstrument, sondern auch zur Plattform für gezielte Zusatzumsätze – von der Buchung neuer Module bis hin zur Einbindung relevanter Fortbildungsangebote oder fachspezifischer Services. Werbung in diesem Kontext bleibt optional, klar getrennt vom Patient:innenbereich und auf qualitativ hochwertige Inhalte begrenzt.

Gleichzeitig schafft das System die Voraussetzung, um perspektivisch auch einen Zugang für Patient:innen zu ermöglichen – mit Rechnungs-, Befund- und Terminzugriff. Doch dieser Schritt muss behutsam, datenschutzkonform und ohne kommerzielle Überfrachtung erfolgen. Die Priorität liegt klar auf der therapeutischen Seite.

SimpliMed ist damit keine klassische Software mehr – sondern eine vertikal integrierte Fachplattform für Heilberufe, die Praxis, Produkt und Perspektive zusammenführt. Ein Investitions- und Wachstumschance, der nicht von Geschwindigkeit lebt, sondern von Passung, Präzision und Praxisnähe.